IDENTIFICAZIONE PRECOCE DEL MELANOMA

Sintesi operativa per Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta e specialisti

IN SINTESI La delibera GRT n. 1007/2026 istituisce un percorso selettivo e dedicato alla "Visita per Valutazione Nevi" per soggetti con specifici fattori di rischio. Il percorso non sostituisce la prima visita dermatologica quando è presente una lesione clinicamente sospetta.

1. Finalità e contesto

La DGR Toscana n. 1007/2026 approva un percorso regionale distinto dall'ordinaria prima visita dermatologica, con l'obiettivo di identificare precocemente melanoma e lesioni pigmentate sospette nei soggetti a maggior rischio. Il modello integra medicina generale, pediatria e dermatologia e mira a:

- favorire la diagnosi precoce e la presa in carico appropriata;
- migliorare l'appropriatezza prescrittiva;
- ridurre la pressione sulle liste di attesa dermatologiche;
- aumentare equità e uniformità territoriale di accesso;
- sviluppare teledermatologia e prevenzione territoriale.

Nel 2025 sono state registrate circa 500.000 prescrizioni dermatologiche complessive. Soltanto il 44% delle circa 135.000 prenotazioni di prima visita è risultato entro i tempi previsti; il tempo medio di prima disponibilità è stato di 52,38 giorni. L'analisi di circa 350.000 prescrizioni mostra che il 31,34% era riferito a nevi non neoplastici, evidenziando l'uso della prima visita anche per attività preventive e di monitoraggio.

2. Popolazione target: chi è eleggibile

CRITERIO GENERALE È sufficiente rientrare in almeno una delle condizioni previste per la propria fascia di età. La prestazione è riservata ai soggetti a rischio e non configura uno screening indiscriminato della popolazione.

Pazienti di età inferiore a 18 anni

Condizione di accesso	Criterio
Immunodeficienza	Immunodeficienza congenita o acquisita, comprese terapie immunosoppressive e/o chemioterapiche.
Numero di nevi	Più di 50 nevi.
Nevi congeniti	Presenza di nevi congeniti medi (1,5–19,9 cm), grandi (20–40 cm) o giganti (>40 cm).

Logica di eleggibilità: immunodeficienza OPPURE >50 nevi OPPURE nevi congeniti delle dimensioni indicate.

Adulti di età compresa tra 25 e 70 anni

Condizione di accesso	Criterio
Criterio autonomo	Più di 60 nevi.
Criterio combinato	Più di 40 nevi E almeno uno dei seguenti fattori concomitanti: immunodeficienza congenita o iatrogena documentata; fototipo I–II; capelli rossi (con o senza mutazione MC1R); lavoro foto-esposto; mutazioni genetiche associate ad aumentato rischio di melanoma.

ATTENZIONE ALLE FASCE D'ETÀ Il testo della delibera individua espressamente i minori di 18 anni e gli adulti tra 25 e 70 anni. Non definisce criteri ordinari di accesso per le età 18–24 anni né oltre i 70 anni; in presenza di sospetto clinico resta applicabile il percorso dermatologico appropriato.

3. Modalità di accesso

Ruolo del medico del territorio

Il MMG è il primo livello del percorso: identifica i soggetti eleggibili, promuove la prevenzione primaria e l'autoesame della cute e rileva eventuali lesioni sospette. Per l'età pediatrica, il PLS orienta il percorso in base al quadro clinico.

Prestazione da prescrivere

Scenario	Accesso corretto
Soggetto eleggibile, senza specifico sospetto clinico	Prescrivere "Visita per Valutazione Nevi", da prenotare su agenda dedicata e separata dalla prima visita dermatologica.
Lesione clinicamente sospetta o quadro che richiede approfondimento tempestivo	Prescrivere la prima visita dermatologica con la classe di priorità appropriata secondo le disposizioni regionali vigenti.
Richiesta di rimozione preventiva di lesione benigna/non sospetta	Non rientra nelle finalità del percorso, che esclude prestazioni "preventivo-chirurgiche" prive di indicazione clinica specialistica.

Caso specifico: sospetto nevo di Spitz in età pediatrica

NON INVIARE A "VALUTAZIONE NEVI" Il sospetto di nevo di Spitz o nevo di Spitz atipico formulato dal PLS richiede una prima visita dermatologica con appropriata classe di priorità. Il paziente accede direttamente alle agende dedicate ai casi con sospetto clinico.

Organizzazione dell'offerta e prosecuzione del percorso

- Le Aziende sanitarie devono attivare agende dedicate alla "Valutazione Nevi", separate da quelle delle visite dermatologiche con priorità clinica.
- La prestazione può essere erogata negli ambulatori dermatologici del SSR o attraverso modelli innovativi.
- È prevista una sperimentazione di teledermatologia coordinata da ISPRO, con acquisizione standardizzata di immagini dermatoscopiche e refertazione specialistica a distanza.
- Le Case della Comunità possono fungere da punti di acquisizione delle immagini; possono essere impiegate anche unità mobili con dermatoscopio per aree periferiche o contesti lavorativi.
- In presenza di lesioni sospette, il paziente viene indirizzato al secondo livello: approfondimento dermatologico e, se indicato, biopsia diagnostica.

4. Periodicità della valutazione

Popolazione eleggibile	Cadenza ordinaria
Età pediatrica (<18 anni)	Ogni 3 anni
Adulti (25–70 anni)	Ogni anno
Situazioni individuali motivate	Lo specialista può programmare controlli con periodicità diversa in base al profilo di rischio individuale o all'esito della valutazione dermatologica.

REGOLA PRATICA La periodicità standard non deve essere modificata automaticamente dal prescrittore: eventuali intervalli diversi sono definiti dallo specialista e devono essere sostenuti da specifiche motivazioni cliniche.

5. Percorso decisionale rapido per il prescrittore

Domanda	Se SÌ	Se NO
È presente una lesione o un quadro clinicamente sospetto?	Prima visita dermatologica con priorità appropriata.	Verificare i criteri di rischio.
Il paziente rientra nei criteri di età e rischio della delibera?	"Visita per Valutazione Nevi" su agenda dedicata.	Non utilizzare il percorso dedicato; valutare il bisogno clinico secondo i percorsi ordinari.
Lo specialista ha indicato una cadenza personalizzata?	Seguire la periodicità motivata dallo specialista.	Applicare la cadenza ordinaria: 3 anni in pediatria, 1 anno negli adulti.

6. Ruoli professionali essenziali

Professionista/struttura	Responsabilità principale
MMG	Selezione dei soggetti eleggibili; prescrizione corretta; prevenzione primaria; educazione all'autoesame; riconoscimento del sospetto clinico.
PLS	Gestione del paziente pediatrico; invio a prima visita dermatologica nei sospetti clinici, compreso il nevo di Spitz/Spitz atipico.
Dermatologo	Valutazione specialistica, definizione dell'eventuale cadenza personalizzata e attivazione del secondo livello.
Aziende sanitarie	Attivazione e adeguamento delle agende dedicate; separazione dai percorsi a priorità clinica; continuità assistenziale.
ISPRO	Coordinamento della sperimentazione regionale di teledermatologia.

7. Messaggi chiave da condividere con il paziente

- La valutazione dedicata è riservata a chi presenta specifici fattori di rischio.
- Una lesione nuova, modificata o sospetta non deve attendere il controllo periodico: richiede valutazione clinica e percorso appropriato.
- Il percorso non è finalizzato alla rimozione preventiva di lesioni benigne prive di indicazione specialistica.
- L'autoesame della cute e la prevenzione dell'esposizione eccessiva ai raggi UV restano componenti centrali della prevenzione.